

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BNI LIFE INSURANCE
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN
MANAGED CARE PT BNI LIFE INSURANCE
DI RS PRIMA HUSADA**

Nomor :

Nomor :

Commented [IM1]: Mohon Dilengkapi nomor PKS

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun(../.../.....) oleh dan antara :

Commented [IM2]: Pengisian tanggal oleh BNI life setelah draft Final

1. **PT BNI LIFE INSURANCE**, berdomisili di **Centennial Tower 9th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930**, didirikan dengan Akta Notaris Nomor No. 7 tanggal 3 April 2014 beserta perubahan-perubahannya, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 44 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26846.40.22.2014 tanggal 29 Agustus 2014. Dalam hal ini secara sah diwakili oleh **dr. Okta Sinta Harini** dalam jabatannya selaku **General Manager of Claim & Provider Division** PT BNI Life Insurance, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Surat Kuasa No.002.POA.BL.COO.0623 tanggal 23 Juni 2023 secara sah bertindak untuk dan atas nama PT BNI Life Insurance selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Rumah Sakit Prima Husada**, yang berkedudukan dan berkantor di Banjararum Selatan No 3-7, Singosari, Malang, Jawa Timur didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 26 tanggal 28 November 2009, dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H., Notaris di Kota Malang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01 tahun 2009 tertanggal 31 Desember 2016 10 RUPS. Perseroan Terbatas Disa Prima Medika nomor 10 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanti, S.H, Notaris di Kota Malang dalam hal ini diwakili Endang Susilowati, selaku Direktur Utama PT Disa Prima Medika bertindak dalam jabatannya, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Commented [IM3]: Mohon Dilengkapi dengan mengikuti template PIHAK PERTAMA

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang menyelenggarakan asuransi kesehatan untuk kepentingan Peserta;
- PIHAK KEDUA** adalah Provider penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan Peserta;
- Bahwa untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Peserta, **PIHAK PERTAMA** bermaksud menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan kesehatan untuk Peserta berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Definisi dan Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan sebagai berikut:
 - a. **Alat kesehatan** adalah suplemen yang diberikan kepada Peserta seperti kacamata, alat bantu dengar, gigi tiruan, alat gerak tiruan, implant (IOL, plat, pen, screw, K-Wire dan implant lain);
 - b. **Formularium Obat** adalah daftar obat-obatan yang digunakan untuk perawatan atau terapi tertentu yang dibuat oleh negara, pemerintah daerah, atau rumah sakit.
 - c. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam perhitungan kalender termasuk tanggal merah dan hari libur nasional.
 - d. **Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali hari sabtu, minggu dan hari yang telah ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah.
 - e. **Managed Care** adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara komprehensif dimana pelayanan yang diberikan berjenjang dengan pola rujukan yang terstruktur dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan medis. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Provider yang terseleksi dan telah bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - f. **Pelayanan Kesehatan** adalah pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**, yaitu dalam bentuk pelayanan Rawat Jalan dan/atau dan/atau *Emergency/Gawat Darurat* dan/atau Fasilitas Medis lainnya.
 - g. **Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan** adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis atau sub spesialis yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
 - h. **Peserta** adalah orang yang menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan Kartu Peserta **PIHAK PERTAMA** yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan **PIHAK KEDUA**.
 - i. **Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)** adalah pelayanan yang dilakukan oleh Dokter Umum yang ada di dalam jaringan provider tingkat pertama Penanggung sesuai dengan indikasi medis untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan dasar lainnya dengan atau tanpa obat.
 - j. **Provider** adalah sarana pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan. Provider terbagi atas Provider Tingkat Pertama dan Provider Tingkat Lanjutan;
 - k. **Provider Tingkat Lanjutan** adalah sarana pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** yang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap;
 - l. **Provider Tingkat Pertama** adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan umum yang menyeluruh, dan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif terdiri dari :
 - 1) Provider Tingkat Pertama yang hanya bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**
 - m. **Rawat Inap (RI)** adalah pelayanan yang bersifat spesialis atau subspesialis untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya sesuai indikasi medis, yang dilaksanakan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Penanggung berdasarkan rujukan dari provider tingkat pertama, provider tingkat lanjutan dan/atau Rumah Sakit sebagai provider lain dimana Tertanggung dan anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Para Pihak sepakat untuk saling bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada Peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

1. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah mengatur mekanisme dan hal-hal lainnya terkait prosedur pelayanan kesehatan untuk Peserta **PIHAK PERTAMA**.
2. Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan kesehatan yang dimaksud Perjanjian ini akan diatur lebih rinci sebagaimana diatur dalam **Lampiran I** untuk ruang lingkup dan prosedur pelayanan untuk Peserta **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menerima informasi resume rekam medis dan bukti pelayanan Peserta baik secara *softcopy* atau *hardcopy* apabila diperlukan;
 - b. Melakukan peninjauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA** dan kunjungan Peserta **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Pasal 14 dalam Perjanjian ini;
 - e. Mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dalam Perjanjian ini; dan
 - f. Mengakhiri Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak lulus tahap peninjauan atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12.
 - g. menolak pembayaran tagihan Tarif Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan yang telah dibayarkan adalah tidak benar, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini.
 - h. menagih kembali pembayaran tagihan Tarif Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**, dalam hal terjadi kelebihan bayar tagihan Tarif Pelayanan Kesehatan dan/atau tagihan Tarif Pelayanan Kesehatan dimaksud terbukti adanya unsur perbuatan melanggar hukum.
 - i. Sewaktu-waktu meminta **PIHAK KEDUA** melengkapi Formulir Riwayat Kunjungan Pasien yang terdapat dalam Lampiran V Perjanjian ini apabila diperlukan.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar biaya atas Pelayanan Kesehatan dan obat yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta, baik

Halaman 3

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

terhadap pembayaran sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini;

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur Pelayanan Kesehatan yang disediakan bagi Peserta;
 - b. Memperoleh pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** atas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini;
 - c. Memperoleh Formularium Obat rumah sakit dan ketentuan lain yang berlaku, buku/panduan /leaflet /petunjuk tata cara bagi Peserta untuk memperoleh hak atas Pelayanan Kesehatan dari *Provider* **PIHAK PERTAMA**, format sistem pencatatan dan pelaporan.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan manfaat pelayanan dengan baik dan benar sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Melayani Peserta dengan baik sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku dan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya dengan memberikan resep obat – obatan dan vitamin atau suplemen dengan batas dan jumlah yang wajar (**seperti pemberian obat dengan golongan Generik berlogo terlebih dahulu lalu ke Gol Generik bermerk sebelum ke pemberian Obat Paten**) serta pemberian tarif tindakan kepada peserta sesuai dengan tarif standar yang telah disepakati **PIHAK KEDUA** tercantum dalam pasal 8 ayat 1.
 - c. Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat bagi Peserta yang berpedoman pada Formularium Obat yang telah disepakati;
 - d. Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat-obatan yang tercakup dalam Formularium Obat Rumah Sakit, kecuali dalam keadaan kosong yang dinyatakan secara tertulis oleh pedagang besar farmasi/distributor obat/produsen farmasi setempat;
 - e. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dokter untuk kebutuhan Peserta sesuai dengan jam kerja dokter di **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan penggantinya dalam hal dokter yang disediakan berhalangan dan/atau tidak lagi bekerja atau berpraktik di **PIHAK KEDUA**;
 - f. Sehubungan dengan ketentuan huruf f ayat ini, **PIHAK KEDUA** wajib memastikan bahwa dokter yang bekerja atau berpraktek di **PIHAK KEDUA** memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sebagai dokter dan mematuhi ruang lingkup dan prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - g. Menyediakan dokumen penagihan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** yang diatur pada lampiran Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah;
 - h. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - i. Mengizinkan sepenuhnya **PIHAK PERTAMA** untuk melihat dan mengakses resume rekam medis dan bukti pelayanan Peserta baik secara pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* apabila diperlukan;
 - j. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** atau secara sendiri melaksanakan program Promotif dan Preventif kepada Peserta.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- k. mengembalikan Tarif Pelayanan Kesehatan yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam hal terjadi kelebihan bayar tagihan Tarif Pelayanan Kesehatan dan/atau tagihan Tarif Pelayanan Kesehatan dimaksud terbukti adanya unsur perbuatan melanggar hukum.
- l. Melengkapi Formulir Riwayat Kunjungan Pasien yang terdapat dalam Lampiran V Perjanjian ini apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 KELAS/KAMAR PERAWATAN

Dalam hal Peserta harus menjalani Rawat Inap di **PIHAK KEDUA**, maka hak atas kelas/kamar perawatan ditentukan sebagai berikut:

1. Hak Peserta **PIHAK PERTAMA** atas kelas/kamar perawatan adalah sesuai dengan kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya sebagaimana tercantum pada Kartu Peserta dari Peserta yang bersangkutan;
2. Dalam hal Peserta atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil kelas/kamar perawatan di atas kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya, maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, tetapi akan menjadi tanggung jawab Peserta, sehingga tidak dapat diuangkan dan tidak dapat diklaim ke **PIHAK PERTAMA**, baik oleh Peserta maupun **PIHAK KEDUA**;
3. Dalam hal kelas/kamar perawatan yang menjadi hak Peserta penuh, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta dirawat di kelas/kamar perawatan yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi, untuk maksimal 2 (Dua) hari perawatan, kecuali untuk Peserta yang telah memiliki hak kelas perawatan kelas 1;
 - b. Peserta yang memiliki hak kelas perawatan kelas 1 dianjurkan untuk memilih Rumah Sakit *Provider* lainnya;
 - c. Apabila hari rawat maksimal sebagaimana dimaksud huruf a di atas terlewati maka selisih biaya yang timbul atas kondisi tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam hal Peserta mengambil kelas/kamar perawatan di atas haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Huruf c Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada Peserta mengenai konsekuensi yang timbul dari hal tersebut dan meminta kepada Peserta untuk menandatangani surat pernyataan sanggup membayar selisih biaya yang timbul.

PASAL 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta adalah tarif yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana tersebut dalam **Lampiran II** Perjanjian ini.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

2. Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku tetap untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini.
3. Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
4. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta sepanjang Pelayanan Kesehatan yang diberikan masih tercakup dalam ruang lingkup serta memenuhi prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 9

BIAYA PELAYANAN OBAT

1. Biaya pelayanan obat bagi Peserta **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Formularium Obat rumah sakit yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta sepanjang pelayanan obat bagi Peserta yang diberikan masih masuk dalam ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

1. Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan obat Peserta oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara kolektif.
2. Waktu pengajuan tagihan:
 - a. Pengajuan tagihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan secara teratur setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. Pengajuan tagihan dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat rujukan dari FKTP
 - 2) surat jaminan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - 3) laporan medis awal yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien
 - 4) resume medis bertandatangan dokter penanggung jawab pasien yang diisi lengkap dan jelas
 - 5) surat kuasa dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Peserta atau anggota keluarga
 - 6) bukti pelayanan lain yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien: laporan operasi, protokol terapi dan jadwal pemberian obat, perincian tagihan rumah sakit, dan berkas pendukung lain yang diperlukan.
 - c. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan reminder atas kekurangan dokumen terhitung sejak tanggal yang tercantum pada surat pemberitahuan *pending claim* tersebut yang akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada Hari Kerja yakni pada hari ke-7, dan hari ke-11. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memberikan respon atas reminder tersebut maka tagihan akan dikembalikan kepada Provider di hari ke-14 kepada yang mana selanjutnya klaim tidak akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dikarenakan kadaluarsa klaim;
 - d. Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak, maka tagihan terakhir dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** wajib diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya Perjanjian ini.
3. Kadarluarsa klaim adalah klaim yang diajukan lebih dari 30 (tiga puluh hari) hari kalender sejak tanggal perawatan terakhir atas pelayanan kesehatan bagi peserta yang dilakukan oleh (Nama Provider Rekanan) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana selanjutnya klaim tidak dapat diproses;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

4. Dokumen klaim diterima oleh BNI Life maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perawatan terakhir atas pelayanan kesehatan bagi peserta yang dilakukan oleh (Nama Provider Rekanan) secara lengkap dan benar, jika melewati jangka waktu tersebut maka BNI Life tidak diwajibkan untuk membayarkan tagihan yang diterima;
5. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal hasil verifikasi terhadap tagihan tersebut **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak pembayaran tagihan atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Apabila **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran dan di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemotongan tagihan bulan berikutnya.

PASAL 11 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan obat oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal **PIHAK PERTAMA** telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan proses verifikasi selesai dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Tagihan yang diajukan lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya bulan pelayanan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini (tanpa ada kesepakatan Para Pihak untuk memperpanjang Perjanjian ini), berhak untuk ditolak atau tidak diproses pembayarannya oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang timbul oleh karena **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan serta pelayanan obat kepada Peserta yang tidak termasuk ke dalam fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan yang menjadi hak Peserta berdasarkan produk yang dipilihnya.
4. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer ke rekening :

Bank : BCA
Cabang : SINGOSARI
No. Rekening : 3683040700
Atas Nama : DISA PRIMA MEDIKA PT

PASAL 12 TAHAP PENINJAUAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti tahap peninjauan dan penilaian kesiapan sebagai provider rumah sakit yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan pemberitahuan tertulis hasil peninjauan dan penilaian yang dilakukan beserta rekomendasi yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak lulus tahap peninjauan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan peninjauan ulang atas

Halaman 7

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Perjanjian ini dan memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan dengan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

PASAL 13 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal bulan..... tahun dan berlaku untuk jangka waktu **5 (Lima) tahun** atau berakhir pada tanggal bulan..... tahun..... (**"Jangka Waktu Perjanjian"**).
2. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dan kehendak untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian tersebut wajib disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Commented [IM4]: Jangka waktu mengikuti selesainya draft final oleh tim HO BNI Life
Apakah bersedia s/d 5 tahun?

PASAL 14 SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak melayani Peserta dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewajibannya sebagai provider;
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan haknya berdasarkan plan yang dipilihnya;
 - c. Memungut biaya tambahan kepada Peserta dari **PIHAK PERTAMA** di luar kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian;
2. Apabila hal-hal sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menagguhkan pembayaran atas tagihan/*invoice* yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh Para Pihak.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan atau kesalahan atau malpraktik yang menimbulkan kerugian bagi Peserta sehingga mengakibatkan Peserta menuntut **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti kerugian dan menghadapi tuntutan yang diajukan oleh Peserta atau Pihak terkait lainnya, serta melepaskan tuntutan hukum terhadap **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini padahal **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui tagihan/*invoice* **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila surat teguran ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c.
5. **PIHAK PERTAMA** berhak tidak membayarkan tagihan jika terdapat adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dimana terdapat adanya kompetensi dokter umum sebanyak 144 diagnosa wajib ditangani pada FKTP yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**. Adapun ketentuan kartu sebagai berikut :
 - a. Kartu Silver : Pelayanan dokter spesialis harus mendapat rujukan dari FKTP
 - b. Kartu Gold : 2 dokter spesialis dapat langsung tanpa melalui rujukan dari

Halaman 8

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- c. Kartu Titanium : RJTP sesuai dengan yang tertera dalam kartu
: 4 dokter spesialis dapat langsung tanpa melalui rujukan dari
RJTP sesuai dengan yang tertera dalam kartu
- d. Kartu Platinum : Pelayanan dokter spesialis tidak dibatasi dapat langsung
tanpa rujukan RJTP dan RJTL

PASAL 15 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal **PIHAK KEDUA** pindah praktik ke lokasi yang tidak disepakati oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak lulus dalam tahap peninjauan sesuai ketentuan pada Pasal 12 Perjanjian ini;
 - c. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) Hari Kerja. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - d. Izin usaha atau operasional **PIHAK PERTAMA** atau izin praktik **PIHAK KEDUA** dicabut oleh pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha, operasional atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - e. **PIHAK PERTAMA** dinyatakan bubar oleh hukum atau bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya putusan pailit oleh Pengadilan;
 - f. **PIHAK PERTAMA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;
 - g. **PIHAK KEDUA** berhenti praktik yang disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - h. Hasil evaluasi dari **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kriteria yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu;
 - i. Salah satu Pihak terbukti melakukan fraud atau melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan.
2. Kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf c Perjanjian ini atau sebagai akibat *Force Majeure*, maka dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian.
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 16
PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai provider yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Peserta telah setuju dan memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk meminta/menerima data medis dari **PIHAK KEDUA**, karenanya **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat gugatan, klaim atau tuntutan hukum dari Peserta yang data medisnya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pemberian kuasa oleh Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** selama masa Asuransi peserta, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** telah melepaskan/mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang berakhirnya kuasa.
3. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kerugian yang timbul dan/ atau tuntutan yang diajukan oleh Peserta dalam hal terjadi tindakan atau kesalahan atau malpraktik pada Peserta yang ditimbulkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan yang diajukan oleh Peserta atau Pihak lain terkait dalam hal terjadi malpraktik yang menyebabkan kerugian bagi Peserta.
5. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin akan memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai dengan ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan bagi Peserta sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini.
6. **PIHAK KEDUA** berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak ketiga lainnya (dalam hal ini termasuk dokter/dokter spesialis/staff medis ataupun staff perawatan lain) untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
7. Mengacu pada ketentuan ayat 6 Pasal ini, dalam hal **PIHAK KEDUA** dan afiliasinya (jika ada) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum termasuk membantu, memfasilitasi terjadinya perbuatan melawan hukum, maka **PIHAK KEDUA** dan afiliasinya (jika ada) akan bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dan afiliasinya (jika ada).

PASAL 18
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara

Halaman 10

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila keadaan memaksa/*Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 19 KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun juga semua data, laporan dan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan data, laporan yang berkaitan dengan Perjanjian ini untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**") kecuali jika informasi dan/atau dokumen tersebut :
 - a. telah diungkapkan di publik oleh Pihak lain selain oleh Para Pihak;
 - b. diungkapkan dengan persetujuan tertulis Para Pihak; atau
 - c. disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau peraturan atau institusi yang berwenang (termasuk diantaranya perusahaan asuransi) atau oleh auditor atau akuntan independen dari masing-masing Pihak.
2. Dalam hal salah satu Pihak melakukan penggandaan dan/atau penyebarluasan informasi, data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Pihak lainnya berhak untuk meninjau kembali Perjanjian ini dan berhak melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu sehubungan dengan hal tersebut.
3. Informasi rahasia tetap harus dijaga oleh Para Pihak sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan serta segala seluruh akibat yang ditimbulkannya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan persoalannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Halaman 11

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

(BANI) untuk diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI, dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tunduk kepada semua keputusan yang ditetapkan oleh BANI.

PASAL 21 PEMBERITAHUAN

- Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, faksimili atau email dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA	: PT BNI LIFE INSURANCE
Alamat Kantor Pusat	: Centennial Tower 9th Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930 – Indonesia
Claim	: Head of Managed Care Department
No. Telepon	: (021) 29539999
No. Facsimile	: (021) 29539998
Alamat Provider Relation	: Gedung BNI Life Insurance Jl. KS. Tubun No. 67, Petamburan, Jakarta Pusat
10260	
Untuk Perhatian	: Provider Contract & Relation
Head Of Provider Relation Departemen	: dr. Tri Maryani Kusuma Astuti
Head Of Provider Relation & Contract	: Lea Destyanti
No. Telephone	: 021-2953 9999 Ext. 6706
Cordinator Provider Relation	: Heru Sutopo
No. Telephone	: 021-2953 9999 Ext. 3820
PIC Managed Care	: Nur Faidah
No. Telepon	: (021) 2953 9999 ext. 3822
No. Facsimile	: (021) 5366 7656/17
Email	: provider.relation@bni-life.co.id

Konfirmasi Penjaminan 24 Jam dan Pengiriman Dokumen

- a. Show Card
 - Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap
 1. Help Desk BNI Life 24 Hours :
 - No Telepon : (021) 27895100 & (021) 53667627
 - Emergency : 08121070922/081380105359 (*Call/Whatsapp*)
 - Alamat Email : provider.helpdesk@bni-life.co.id
 - Pengiriman dokumen :
 - UP : Bagian Klaim Managed Care
 - Alamat : PT. BNI Life Insurance d/a. Centennial Tower
9th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.24-25 Jakarta
12930

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

b. Swipe Card

1. Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap
 Help Line Service BNI Life – Admedika :
 No Telepon : 1-500246
 Alamat Email : **bnilifemc@admedika.co.id**
 Facsimile : (021) 38902079
2. Pengiriman dokumen :
 UP : Bagian Klaim Managed Care BNI Life AdMedika
 Alamat : PT Administrasi Medika d/a. Telkom STO Gambir
 Gedung C Jl. Medan Merdeka Selatan No 12 Jakarta
 Pusat - 10110

Rekonsiliasi Klaim & Penagihan : TeleKlaim
 Telephone : 021 2953 9999 Ext : 2407
 Email : **teleklaim.provider@bni-life.co.id**

PIHAK KEDUA

: RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
 Alamat lengkap : Banjararum Selatan No 3-7 Mondoroko, Singosari
 Malang, Jawa Timur
 No. Telepon : 0341-458679
 No. Facsimile : 0341-441874
 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Untuk Perhatian :
 Bagian Marketing : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
 No. HP : 08113507164
 Email : marketingrsph@gmail.com

Bagian Keuangan : Novi Ratnasari, SE
 No. HP : 0341(458679) ext 135
 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

Bagian Administrasi : Lilik Kurniati
 No. HP : 081331429720
 Email : admklaim.rsph@gmail.com

Bagian Kasir : Novi Ratnasari, S.E
 No. HP : 081217904143
 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com
 Kode Provider Layanan Admedika :

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu Pihak, kepada Pihak lainnya secara tertulis.

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui teleks atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman teleks, konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili dan *sent* pada pengiriman email.

Commented [IM5]: Mohon Dilengkapi kode admedika

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 22
ADDENDUM DAN SIDE LETTER PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan/penambahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk *Side Letter*.
3. Baik Addendum maupun *Side Letter* merupakan bagian yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian ini dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 23
HAK PEMERIKSAAN DAN EVALUASI

1. Para Pihak berhak dan wajib untuk melakukan evaluasi secara periodik paling tidak dilakukan setiap 3 bulan sekali selama jangka waktu Perjanjian
2. Salah satu Pihak memiliki hak untuk melakukan evaluasi sewaktu-waktu baik selama jangka waktu Perjanjian atau setelah Perjanjian berakhir maksimal 2 tahun sejak tanggal efektif pegakhiran Perjanjian
3. Salah satu Pihak berhak untuk menunjuk perwakilannya dan/atau pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan/audit atas pelaksanaan Perjanjian ini baik pada saat Perjanjian ini masih berlaku atau Perjanjian ini sudah berakhir dengan ketentuan sebagaimana ayat 2 Pasal ini, dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis paling tidak 14 hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan/audit dilakukan oleh salah satu Pihak di tempat Pihak lainnya.

PASAL 24
KETENTUAN ANTI KORUPSI/PENYUAPAN

1. Para Pihak tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Para Pihak dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan anti pencucian uang dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik atau rekan-rekan mereka, keluarga atau teman dekat.
2. Para Pihak setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima, atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, atau jika salah satu Pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh Pihak lainnya, maka Pihak yang meyakini tersebut boleh mengakhiri Perjanjian ini dengan segera.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 25
ITIKAD BAIK

1. Para Pihak menjamin bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk memberi keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 26
LAIN-LAIN

1. Keterpisahan
Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka Para Pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
2. Perubahan
Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Batasan Tanggung Jawab
PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar syarat ketentuan pada Perjanjian ini dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.
4. Perbedaan Penafsiran
Apabila terdapat perbedaan penafsiran, interpretasi, makna antara Perjanjian dan Lampiran pada Perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan yang tertera pada Perjanjian.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PT BNI Life Insurance

PIHAK KEDUA
PT Disa Prima Medika

dr. Okta Sinta Harini
General Manager of Claim & Provider
Division

Endang Susilowati
Direktur Utama

Commented [IM6]: Mohon Dilengkapi

Halaman 15

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

LAMPIRAN I

Nomor :

Nomor :

Commented [IM7]: Mohon Dilengkapi nomor PKS

**PETUNJUK TEKNIS
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PT BNI LIFE INSURANCE
DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Petunjuk teknis ini berlaku untuk pelayanan kesehatan bagi Peserta PT BNI Life Insurance.

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

1. Peserta yang datang ke Rumah Sakit membawa kartu asuransi PT BNI Life Insurance dan surat rujukan dari *Provider* Tingkat Pertama.
2. Surat Rujukan dari *Provider* Tingkat Pertama berlaku selama 30 hari kalender sejak surat diterbitkan untuk satu kasus dengan maksimal 4 kali kunjungan.
3. Peserta dengan plan Gold dapat langsung ke dua dokter spesialis (THT, Mata)
4. Peserta dengan plan Titanium dapat langsung ke empat dokter spesialis (THT, Mata, Anak, Obgyn)
5. Peserta dengan plan Platinum dapat langsung ke semua dokter Spesialis
6. Jika diperlukan rujukan internal maka diberikan langsung surat rujukan/konsul internal di dalam lingkungan RS tersebut dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
7. Jika diperlukan rujukan *eksternal* maka diberikan surat rujukan/konsul eksternal dari RS pengirim ke RS rujukan. Dan surat rujukan/konsul eksternal dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pelayanan Rawat Inap (RI)

1. Pelayanan Rawat Inap (RI) dapat diberikan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan paket dan plan yang tertera di kartu kepesertaan dengan membawa dan menunjukkan kartu kepesertaan, identitas diri serta surat permintaan rawat inap dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)/Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)/permintaan rawat inap (RI) dari dokter IGD.
2. Pengurusan administrasi untuk rawat inap dapat dilakukan oleh Tertanggung atau peserta /keluarga paling lambat diberikan dalam kurun waktu 2x24 jam sejak Tertanggung atau peserta memasuki perawatan.
3. **PIHAK KEDUA** mengkonfirmasi permintaan rawat inap kepada bagian penjaminan **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan.
4. Petugas penjaminan **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan kelengkapan administrasi berupa formulir rawat inap, surat pernyataan dan surat kuasa kepada **PIHAK KEDUA** yang harus dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA** dan Tertanggung atau peserta.
5. Setelah dokumen dilengkapi, kemudian **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan kelengkapan berkas administrasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut.

Halaman 16

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

6. Kemudian Petugas penjaminan dari **PIHAK PERTAMA** akan meneliti kelengkapan dan keabsahan surat permintaan rawat inap serta dokumen medis yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. Apabila dari dokumen yang sudah dianalisa dinyatakan layak untuk mendapatkan jaminan maka bagian penjaminan akan menerbitkan surat jaminan awal kepada **PIHAK KEDUA**.
8. Namun apabila dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan jaminan maka bagian penjaminan akan menerbitkan surat tolakan kepada **PIHAK KEDUA**.
Penolakan dapat terjadi karena :
 - a. Perawatan rawat inap tidak ada indikasi medis
 - b. Diagnosa termasuk kedalam pengecualian polis
 - c. Tidak sesuai dengan ketentuan prosedur yang sudah ditetapkan
9. Selanjutnya bagian penjaminan akan melakukan monitoring sampai Tertanggung atau Peserta dinyatakan pulang oleh dokter yang merawat.
10. Setelah Tertanggung atau peserta dinyatakan pulang, **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan berkas kepulangan yang berisi detail perincian biaya perawatan dan resume medis akhir.
11. Kemudian petugas penjaminan dari pihak penanggung akan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen medis akhir tersebut yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
12. Apabila terdapat kelebihan biaya yang tidak ditanggung dari manfaat yang dimiliki, maka Tertanggung atau Peserta harus menyelesaikan biaya tersebut sebelum kepulangan.
13. Apabila dari dokumen yang sudah dianalisa dinyatakan layak untuk mendapatkan jaminan maka bagian penjaminan akan menerbitkan surat jaminan akhir kepada **PIHAK KEDUA**.
14. Namun apabila dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan jaminan maka bagian penjaminan akan menerbitkan surat tolakan kepada **PIHAK KEDUA**.
15. Tertanggung atau Peserta akan menandatangani bukti pelayanan setelah mendapatkan pelayanan RI.
16. Setelah mendapatkan pelayanan rawat inap, beberapa kemungkinan sebagai tindak lanjut bagi Tertanggung atau peserta adalah :
 - a. Tertanggung atau peserta pulang, tetapi diminta untuk kontrol kembali.
 - b. Tertanggung atau peserta di rujuk eksternal.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

LAMPIRAN II

Nomor :

Nomor :

Commented [IM8]: Mohon Dilengkapi nomor PKS

**TARIF PELAYANAN
KESEHATAN**

1. **PIHAK KEDUA** akan memberikan potongan 0% (nol persen) dari total tagihan kepada **PESERTA**.
2. Nominal total tagihan yang diajukan ke BNI Life adalah jumlah total tagihan yang sudah di berikan potongan diskon kepada BNI Life, serta menginformasikan nominal total tagihan sebelum potongan diskon dalam satu format.
3. **PIHAK KEDUA** menginformasikan billing perbandingan apabila peserta menempati tingkatan di atas planya, baik atas indikasi kamar tidak tersedia, penuh atau APS.
4. **PIHAK PERTAMA** akan mengikuti ketentuan Harga Tindakan sesuai tarif standar yang telah disepakati bersama yang berlaku di PIHAK KEDUA
5. **PIHAK KEDUA** sepakat menentukan besarnya biaya administrasi untuk pelayanan **rawat inap** sesuai dengan buku tarif yang berlaku di Rumah Sakit.

Commented [IM9]: Mohon Dilengkapi

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

LAMPIRAN III**Nomor :****Nomor :****Commented [IM10]:** Mohon Dilengkapi nomor PKS**CONTOH KARTU**

 OPTIMA MANAGED CARE PT INDO TECH PERKASA Nama Peserta : YUKE PERMATA LISNA (LIP) Nomor Peserta : 06A00201400099,1752 Tanggal Lahir : 25/10/1989 Rawat Inap : Kelas II Rawat Jalan Tingkat Pertama : Klinik Klinik Farmasi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan : Dokter Spesialis dengan rujukan Manfaat Tambahan : Tidak dijamin Manfaat Khusus : Tidak dijamin Paket : BNI Life Care Masa Berlaku: 25/10/2014 s.d 30/09/2015 SILVER	Pelayanan yang diberikan mulai dari kelas II dan kelas I pada provider kesehatan dengan cakupan layanan hanya berlaku maksimal untuk Provider Provinsi
 OPTIMA MANAGED CARE PT INDO TECH PERKASA Nama Peserta : YUKE PERMATA LISNA (LIP) Nomor Peserta : 06A00201400099,1752 Tanggal Lahir : 25/10/1989 Rawat Inap : Kelas II Rawat Jalan Tingkat Pertama : Klinik Klinik Farmasi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan : Dokter Spesialis dengan rujukan (kecuali Mata dan THT) Manfaat Tambahan : Reimbursement Manfaat Khusus : Tidak dijamin Paket : BNI Life Care Masa Berlaku: 25/10/2014 s.d 30/09/2015 GOLD	pelayanan kesehatan berjenjang Managed Care mulai dari kelas II, kelas I dan kelas VIP pada provider kesehatan dengan cakupan layanan hanya berlaku maksimal untuk Provider Nasional. Khusus untuk pelayanan 2 (dua) dokter spesialis (Mata dan THT) dapat langsung tanpa melalui rujukan dari RJTP.
 OPTIMA MANAGED CARE PT INDO TECH PERKASA Nama Peserta : YUKE PERMATA LISNA (LIP) Nomor Peserta : 06A00201400099,1752 Tanggal Lahir : 25/10/1989 Rawat Inap : Kelas II Rawat Jalan Tingkat Pertama : Klinik Klinik Farmasi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan : Dokter Spesialis dengan rujukan (kecuali Mata, THT, Anak & Kandungan) Manfaat Tambahan : Reimbursement Manfaat Khusus : Reimbursement Paket : BNI Life Care Masa Berlaku: 25/10/2014 s.d 30/09/2015 TITANIUM	pelayanan kesehatan berjenjang Managed Care mulai dari kelas II, kelas I, dan kelas VIP pada provider kesehatan dengan cakupan layanan hanya berlaku maksimal untuk Provider Nasional. Khusus pelayanan 4 (empat) dokter spesialis (Mata, THT, Anak & Obsgyn) dapat langsung tanpa melalui rujukan dari RJTP.
 OPTIMA MANAGED CARE PT INDO TECH PERKASA Nama Peserta : YUKE PERMATA LISNA (LIP) Nomor Peserta : 06A00201400099,1752 Tanggal Lahir : 25/10/1989 Rawat Inap : Kelas II Rawat Jalan Tingkat Pertama : Klinik Klinik Farmasi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan : Dokter Spesialis tanpa rujukan Manfaat Tambahan : Reimbursement Manfaat Khusus : Reimbursement Paket : BNI Life Care Masa Berlaku: 25/10/2014 s.d 30/09/2015 PLATINUM	pelayanan kesehatan berjenjang Managed Care mulai dari kelas VIP dan kelas VVIP dengan cakupan layanan berlaku maksimal untuk Provider Nasional dan Luar Negeri (jika ada). Pelayanan dokter spesialis tidak dibatasi dapat langsung tanpa rujukan RJTP dan RJTL.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

LAMPIRAN IV

Nomor :

Nomor :

Commented [IM11]: Mohon Dilengkapi nomor PKS

FORMULIR RUJUKAN

Surat Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama
Klinik / Praktek Dokter Umum / Gigi

Peserta Asuransi PT BNI Life Insurance - Managed Care



No Rujukan	:	_____	
No BPJS	:	_____	
Nama Faskes Tingkat 1	:	_____	
Alamat	:	_____	No Telepon : _____

Kepada Yth TS, Dr Spesialis	:	_____	
Di Rumah Sakit / Lab	:	_____	
Mohon Pemeriksaan Dan Penanganan	:	_____	
Lebih Lanjut Untuk Pasien	:	_____	
Nama	:	_____	Umur / Jenis Kelamin : _____
No Kartu Asuransi	:	_____	Status Peserta : _____
Keluhan	:	_____	
Pemeriksaan Penunjang	:	_____	
Yang Telah Dilakukan	:	_____	
Diagnosa	:	_____	
Therapy yang sudah diberikan:	:	_____	
Demikian informasi rujukan yang dapat saya sampaikan, Terima kasih.			
Salam sejawat,	:	_____	Tempat dan Tanggal : _____

Dari R.S.	:	_____	
Yth. Dokter	:	_____	
Di	:	_____	
Bersama ini kami kirimkan kembali Pasien			
Nama	:	_____	
Umur	:	_____	
Alamat	:	_____	
Dengan Diagnosa Awal	:	_____	
Diagnosa Akhir	:	_____	
Terapi / Tindakan	:	_____	
Yang Telah Dilakukan	:	_____	
Saran	:	_____	
Keterangan Lain-Lain	:	_____	
Kontrol Kembali	:	_____	
Telah Meninggal Tanggal	:	_____	
Salam sejawat,	:	_____	Tempat dan Tanggal : _____

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower, 9th Floor, Jl. Gatot Soebroto Kav.24-25, Jakarta 12930
Phone: (+6221)-2953 9999 (Hunting), Fax: (+6221)-2953 9999, www.bnilife.co.id

LAMPIRAN V

PKS.CLC.VIII.C.00.0623

Halaman 20

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Nomor :

Nomor :



Commented [IM12]: Mohon Dilengkapi nomor PKS

FORMULIR RIWAYAT KUNJUNGAN PERAWATAN PASIEN
(Diisi oleh Dokter / Penanggungjawab Bagian Rekam Medis)

No. Rekam Medis :
 No. Identitas KTP :
 Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat :

No.	Tanggal Perawatan	Diagnosa	Jenis Perawatan	Tanda Tangan Dokter / Bidan Penanggungjawab Rekam Medis serta stempel Klinik / Rumah Sakit / dokter
1	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	
2	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	
3	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	
4	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	
5	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	
6	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	
7	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	
8	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	
9	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	
10	 s/d		Rawat inap Rawat jalan	

Catatan :

- Formulir harap diisi dengan lengkap ,
- Formulir dapat diisi oleh dokter / bidan ataupun penanggungjawab rekam medik mengikuti peraturan yang berlaku di rumah sakit / klinik / praktek.
- Formulir dapat diperbanyak sesuai kebutuhan informasi yang tersedia.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2